

• 药物与临床 •

药物相互作用

十三、解热—镇痛—非甾体抗炎药	处 理
非甾体抗炎药(NSAID)的共同相互作用 • 抗凝药(华法林、肝素、溶栓药):多数 NSAID 均有抗血小板作用,可加重出血倾向。 • 糖皮质激素:增强抗炎效果,但对消化道粘膜的损害加重。 • 乙醇:加强胃粘膜损害。 • 尿碱化药、抗酸药(长期服用):本类药物多数为有机酸类,尿碱化可使 NSAID 的排泄增加。 • 尿酸化药:NSAID 排泄减少。 • 呋塞米:NSAID 抑制肾脏的前列腺素合成,减弱排钠和抗高血压作用。 • 对乙酰氨基酚:长期应用可显示肾毒副作用增强。 • 锂盐:减少锂排泄,血药浓度和毒性均增加。 • 齐多夫定:排泄减少,毒性增强。 • 甲氨蝶呤:肾排泄减少,血药浓度升高,毒性增强。	谨慎,监测凝血功能 谨慎使用 戒酒 提防药物贮留 24 小时前停用 NSAID
阿司匹林(NSAID) • 氨基糖苷类:耳毒性加强。 • 胰岛素、口服降糖药:降糖效应加强。 • 丙磺舒和磺吡酮:排尿作用因阿司匹林联用而降低。水杨酸盐的尿排泄因丙磺舒而减少。	提高警惕
对乙酰氨基酚(不属于 NSAID) • 乙醇(嗜酒者)、肝酶诱导剂(苯巴比妥、利福平等):加速药物代谢,较多地生成肝毒性的乙酰肼,可造成肝损害。 • 抗凝药、溶栓药:对乙酰氨基酚抑制肝脏减少凝血因子的合成,增强抗凝药作用。 • 阿司匹林、水杨酸盐或其他 NSAID:长期联合应用,明显增加肾毒性,致肾乳头坏死、肾癌、膀胱癌。	警惕 监测凝血酶原 警惕
吡罗昔康(NSAID) • 丙磺舒:萘普生排泄减少,疗效和毒性均增强。	
吲哚美辛(NSAID) • 洋地黄类:吲哚美辛抑制洋地黄类的肾排泄,毒性增强。 • 氨苯蝶啶:联用时可致肾功能减退(Clcr 下降等)。 • 秋水仙碱、磺吡酮:联用致胃肠溃疡及出血。 • 甲氨蝶呤:甲氨蝶呤的血浓度升高并持续。 • 硝苯地平、维拉帕米:血浓度升高、毒性增强。	监测并加强观察 在 1~2 日前停吲哚美辛,方可用药
布洛芬 • 维拉帕米、硝苯地平:使布洛芬血浓度升高。 • 地高辛:地高辛血浓度升高,注意调整剂量。 • 抗高血压药:对降压效果有影响。	监测 注意、避免不良作用
酮洛芬(NSAID) 药物相互作用与布洛芬近似。 • 丙磺舒:酮洛芬血浓度明显提高,可致毒性反应。 • 阿司匹林:降低酮洛芬的蛋白结合率影响代谢和排泄。	注意一般禁用 注意

双氯芬酸钠(钾)(NSAID) • 胰岛素:降糖作用减低,血糖升高。 • 保钾利尿药:可引起血钾显著升高。 • 阿司匹林:双氯芬酸的生物利用度降低。	避免联用 注意监测血钾 注意
十四、抗痛风药	处 理
秋水仙碱 • 中枢抑制药:中枢抑制作用加强。 • 拟交感神经药:作用加强。 • 维生素 B₁₂:影响消化道中维生素 B₁₂的吸收。 丙磺舒 • 利尿药(噻嗪类、氯噻酮、依他尼酸等)以及吡嗪酰胺、乙醇:均可提高血清尿酸浓度,抵消本品作用。 • 阿司匹林及水杨酸盐:降低本品排尿酸作用。 • 吡喹酮、氯喹、奎宁、氯苯磺胺:这些药物的血浓度升高,毒性加强。 • 口服降糖药:降糖效应加强。 • 甲氨蝶呤:甲氨蝶呤血浓度升高,毒性增大。 • 呋喃妥因:呋喃妥因由于肾小管分泌受抑制,尿中浓度降低。 • 磺胺药:血浓度升高。 别嘌醇 • 利尿药、吡嗪酰胺、乙醇:相互作用同丙磺舒(见前)。 • 抗凝药:抗凝药血浓度升高,作用加强,有危险。 • 硫唑嘌呤、巯嘌呤:因黄嘌呤氧化酶受抑制而别嘌呤的代谢受阻,血药浓度升高毒性增强。 • 环磷酰胺:骨髓抑制加重。 • 氨苄西林:对高尿酸血症患者联用可使皮肤过敏反应增多。	注意 注意 加强检验并调整丙磺舒用量 加强检验血糖 监测 避免联用 加强检测

(待续)

药源性低血糖反应 13 例临床分析

甘 泽

低血糖反应是糖尿病患者在治疗过程中常见的并发症。近年来,药源性低血糖的发生率有明显增加趋势。为有效预防糖尿病患者低血糖反应的发生,做到早期诊断、合理治疗,现将我院 1998 年 1 月至 2001 年 6 月在门诊及住院诊治的 13 例作一分析。

1 临床资料

1.1 一般资料 本组 13 例中男 9 例,女 4 例,年龄 45~76 岁,其中 45~60 岁 3 例,61~70 岁 8 例,71~76 岁 2 例。病程 1~18 年。根据 WHO 糖尿病诊断标准,确诊为 1 型糖尿病 2 例,2 型糖尿病 11 例。

1.2 低血糖诊断 本组 13 例均参照刘新民^[1]所定标准作出诊断,即(1)以血浆血糖浓度<3.0 mmol/L;(2)有中枢神经系统功能失常所致的症状或交感神经过度兴奋症状;(3)使用葡萄糖治疗后症状好转。

1.3 用药情况 本组口服药物引起者 10 例,其中优降糖和消渴丸合用者 6 例,格列齐特(达美康)与消渴丸合用者 2 例,单用优降糖 2 例。应用胰岛素引起者 3 例,其中 2 例发生在餐前注射胰岛素后未按时进食,1 例在静滴胰岛素时自己调快滴速。

1.4 临床表现 本组 13 例均有不同程度的饥饿感、出冷汗、心悸、头晕、乏力等症状,其中以饥饿感、出冷汗为主要表现者 6 例,以心悸、头晕为主要表现 3 例,以全身软弱、无力为主要表现 2 例,出现手颤、抽搐及轻度昏迷各 1 例。

1.5 血糖检查 全部病例血糖均≤3.0 mmol/L,其中血糖 2.0~2.8 mmol/L 7 例,2.9~3.0 mmol/L 6 例。尿糖均阴性,尿酮体阴性,电解质正常。

1.6 治疗及转归 一经确诊后即予以口服葡萄糖水或给予含糖饮食,静脉注射 50%葡萄糖液 40~60 ml。昏迷患者予以 5%葡萄糖液静滴维持,直至清醒为止。结果:13 例经上述治疗后症状消失,血糖恢复正常,无死亡病例。

2 讨论

作者单位:543202 广西壮族自治区岑溪市南渡镇中心卫生院